

· 论 著 ·
(疝与腹壁外科专题)

腹壁韧带样瘤六例诊治分析及文献复习

杨志 林龙英 王家兴

〔摘要〕 目的 探讨腹壁韧带样瘤的诊断和治疗。方法 回顾性分析攀钢集团总医院 1999 年 3 月至 2015 年 1 月收治的 6 例腹壁韧带样瘤病人的临床资料。病人以腹部包块入院,无特异性的临床表现。治疗上均选择以手术治疗为主,术中保留皮肤及皮下组织,沿肿瘤边缘完整游离肿瘤,距离肿瘤边缘大于 2 cm 完整切除肿瘤,将切除的肿瘤送冰冻病理检查,若切除的肿瘤边缘为阳性,则继续扩大切除范围。手术后若腹壁缺损较大,则用补片予以修补,术后予以放疗。结果 6 例病人中女性 5 例,均为经产妇,1 例为男性;均因为发现腹壁包块入院就诊,术前经过彩超或 CT 检查证实肿块位于腹壁,肿瘤最长径在 2.7~7.9 cm 之间,平均为 5.6 cm。6 例病人均经手术广泛切除治疗,其中 2 例接受术后放疗。术后随访 7~361 个月,复发者 1 例(未接受术后放疗),复发率为 16.67%。结论 腹壁韧带样瘤为临床少见疾病,发展缓慢,无特异性临床表现,以女性好发,治疗上以外科手术为主,术后放疗可降低复发率。

〔关键词〕 韧带样瘤;外科手术;诊断;放疗

〔中图分类号〕 R735.5 **〔文献标识码〕** A **〔DOI〕** 10.3969/j.issn.1003-5591.2017.03.010

腹壁韧带样瘤又称韧带样纤维瘤、硬纤维瘤或侵袭性纤维瘤病,临床少见,好发于肌肉、筋膜、腱膜,局部侵袭性生长的软组织肿瘤,易复发。1999 年 3 月至 2015 年 1 月我院收治 6 例经术后病理确诊的韧带样瘤病人,现对此 6 例进行总结并结合相关文献复习报告如下。

资料与方法

一、一般资料

本组 6 例,男性 1 例,女性 5 例,年龄 23~65 岁,平均年龄为 38.1 岁。男性 1 例,无特殊病史;5 例女性全部已婚、经产妇,其中生育 1 胎 2 例,生育 2 胎 2 例,生育 3 胎 1 例;有剖宫产病史 5 例。

二、临床表现及辅助检查

6 例病人均以发现腹部无痛性肿块入院,肿块生长缓慢,呈扁圆形或梭形,质地硬,边界欠清,表面光滑,活动度差。病程在 1~23 个月,肿瘤最长径在 2.7~7.9 cm,平均为 5.6 cm。术中发现肿瘤位于腹外斜肌腱膜与腹内斜肌间 4 例,腹内斜肌 1 例,腹横肌 1 例。术前经彩超或 CT 证实肿块位于腹壁,所有病例

术后病理检查均证实为韧带样瘤(图 1、2)。

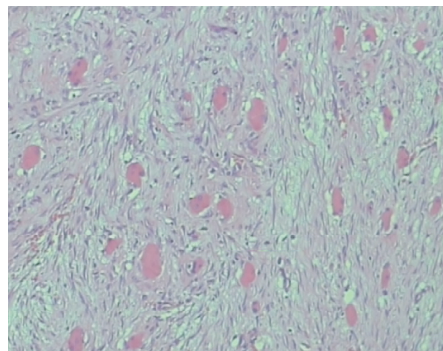


图 1 肿瘤切除后病理切片(HE 染色,×100) 腹壁横纹肌由条索状纤维细胞/纤维母细胞和胶原纤维组成,肿瘤细胞呈梭状排列,边界不清,浸润性生长

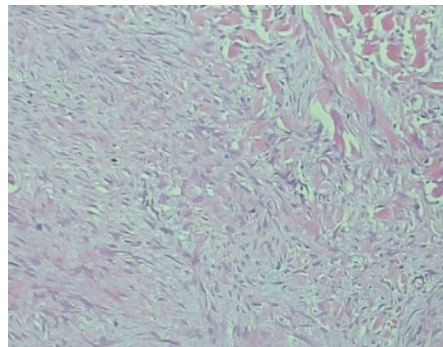


图 2 肿瘤切除后病理切片(HE 染色,×100) 肿瘤呈浸润性生长,边界不清

作者单位:617000 四川攀枝花,攀钢集团总医院普外科
通信作者:杨志,Email:yangzhidoc@163.com

三、治疗方法

本组病人均行外科手术治疗,术中均预约冰冻病理检查,术前根据彩超及 CT 检查结合体检情况决定手术切口,术前标记肿瘤范围及切口。手术中保留皮肤及皮下组织,沿肿瘤边缘完整游离肿瘤,距离肿瘤边缘大于 2 cm 完整切除肿瘤,将切除的肿瘤送冰冻病理检查,若切除的肿瘤边缘为阳性,则继续扩大切除范围。本组病例中,2 例将腹直肌及肿瘤一并切除,术后缺损范围较大,用巴德补片(Bard Composix)修剪后修补于缺损处,创腔内放置引流管,术后负压吸引引流。术后 10 d 左右拆线,腹部腹带固定 3 个月。2 例病人术后予以放疗。

四、随访

本组病人术后均随访,每 3~6 个月到门诊随访,随访内容为观察切口愈合情况,有无切口疝形成,体检触诊有无肿瘤复发,每半年行彩超或 CT 检查。重点了解肿瘤原发部位有无肿瘤复发,每次随访时还注意有无腹壁其他部位出现肿瘤。

结 果

6 例病人手术均行扩大切除,2 例切除后用人工补片修补缺损腹壁。术后未出现切口感染、腹壁切口疝等并发症,无术后死亡病例。6 例病人术后均得到随访,术后随访 7~361 个月,术后有 2 例病人接受术后放疗,未接受放疗的病人中有 1 例在术后随访至 27 个月时出现复发(总体复发率为 16.67%),复发见肿瘤大小约 2 cm,予以再次手术切除,术后继续随访 69 个月,未见肿瘤再次复发。

讨 论

韧带样瘤又称侵袭性纤维瘤病、硬纤维瘤或带状瘤,通常起源于深部筋膜及肌腱膜结构,是由单克隆纤维母细胞或肌纤维母细胞增生而形成的纤维性肿瘤,以局部浸润为主,不发生远处转移的中间型肿瘤^[1-2]。病理形态上虽无异常核分裂象,但生物学行为呈侵袭性生长,易复发,所以从临床角度应认为是低度恶性肿瘤。韧带样瘤发病率较低,约(0.24~0.43)/10 万^[3],约占所有肿瘤的 0.03%,占软组织肿瘤的 3%^[4]。目前认为韧带样瘤形成的分子遗传学机制主要为 APC 基因失活突变或 β -catenin 基因激活突变导致核内 β -catenin 水平上调,Wnt 通路被激活,激活下游的靶基因如 c-myc、cyclinD1 及环氧化酶-2(COX-2)等的转录,引起纤维细胞增殖和分化失控^[5];染色体异常如 8 号染色体三体,20 号染

色体三体和 Y 染色体缺失导致肿瘤形成已有报道^[6]。

其病因较复杂,可能与创伤、内分泌及遗传等因素有关^[7-8],腹壁韧带样瘤在临床上少见,青年女性为好发人群,发病部位一般位于腹壁、肢体及头面部,多为单发。病变主要累及肌肉和肌腱,一般先局限于一块肌肉,逐渐发展累及相邻的肌肉,形成巨大肿块。肿瘤生长缓慢,可以无伴随症状,临床表现不典型,一般表现为逐渐增大的肿块,肿块质地硬,边界不清,活动度欠佳,当肿瘤生长到较大后,可因为肿瘤的压迫出现症状,当肿瘤包绕周围神经时,可伴疼痛、麻木、感觉异常。确诊需要根据术后病理检查,其术后的病理组织学特征:镜下肿瘤组织中胶原纤维比例较高,可见细胞外胶原纤维明显增生。若纤维细胞比例少,则以成纤维母细胞为主,部分有肌成纤维细胞特征。

本组病例中经产妇的发病率在 83.3%,也提示该病可能受内分泌影响,可能是因为在生育年龄,与体内的内分泌激素失衡相关。也有人认为与创伤相关,对于经产妇而言,创伤主要来源于两方面,一是妊娠期间,由于胎儿的生长,导致腹壁过度牵拉,分娩时腹壁肌肉强烈收缩,均可以导致腹部肌纤维损伤,导致肿瘤的发生;另一方面,剖宫产也被认为是导致肿瘤发生的因素之一,原因在于剖腹过程中肌肉离断的创伤导致肿瘤的发生。但该种发病因素的猜想也有其不合理的方面,比如腹部外科多为剖腹手术,若按照此理论,则剖腹手术后的病人应该为高发人群,然而现实中却并不是这样,所以,我们认为可能是在一定的激素环境下的创伤,才是致病因素之一。国内有学者^[9]发现,可用荧光原位杂交方法(FISH)在石蜡组织中检测 8 号染色体三体阳性率为 30%,原发病例的 8 号染色体三体阳性率显著低于复发病例,从而提示该病的发生可能与遗传相关。

由于本病的发生隐匿、发展缓慢,无特异性的临床表现,所以,在临床工作中,容易被误诊、漏诊。但对于有以下特点的病人,我们应该高度警惕该病存在的可能性:①因为腹部无痛性包块就诊的年轻女性,特别是经产妇;②有剖宫产手术病史的女性出现的下腹部包块;③体格检查时发现的类圆形或梭形包块,边界不清、活动度差,无压痛;④经彩超、CT 等检查发现的呈侵袭性生长的肿瘤,肿瘤主要位于腹壁肌肉层;⑤腹壁韧带样瘤切除术后再次出现的肿瘤原发部位的肿块,更应该高度怀疑该病。

目前,对于腹壁韧带样瘤,尚缺乏统一的治疗标准。但普遍认为手术为该病的治疗首选方法。因该病复发率较高,有报道复发率为 20%~70%^[10-11],但转移出现的少,治疗上主要达到局部控制,一般选择行广泛切除,包括病灶周围 2~3 cm 的正常组织^[12-13]。但该病呈侵袭性生长,手术中可能因为肿瘤较大,广泛切除后担心腹壁缺损。对于此类病人,所以我们采取术中行冰冻病理检查,若切除肿瘤的边缘为阴性,则认为到达安全切缘,术中可准备人工补片,对于肿瘤较大者,目前可用聚丙烯补片或复合补片修补切除后薄弱的腹壁^[14]。术中若放置人工补片,在创腔内留置引流管,术后负压吸引引流,可以减少创腔内血肿的形成,减少补片感染的概率。放疗被认为能显著提高疗效的治疗手段^[15]。本组病例中未行放疗的 2 例中有 1 例出现了术后复发。而且放疗对于失去手术机会者,或手术切除后出现切缘阳性的病人,在控制肿瘤生长及促进肿瘤消退方面,更是一种重要的治疗措施。药物治疗方面,有报道行雌激素受体检测呈阳性者给予口服三苯氧胺维持治疗,肿瘤进展明显放缓^[16],非甾体类抗炎药可以通过抑制 COX-2 达到治疗作用,秋水仙碱可以抑制细胞分裂,控制肿瘤的生长,但药物治疗尚缺乏大宗的随机对照研究。

腹壁韧带样瘤发病隐匿,无典型的临床表现,容易被误诊和漏诊,在手术切除以前或术中冰冻切片中常很难做出正确的诊断^[17]。本组病例在术前诊断的时候均为韧带样瘤的诊断,均以腹壁包块入院及手术,应该提高对该病的警惕性,做到早发现、早诊断、早治疗。治疗上,首选手术切除,术后放疗对于提高疗效有一定的帮助。

参 考 文 献

- Gounder MM, Lefkowitz RA, Keohan ML, et al. Activity of sorafenib against desmoids tumor/deep fibromatosis. *Clin Cancer Res*, 2011, 17: 4082-4090.
- Berrj RN, Baumann DP, Madewell JE. Desmoid tumor; current multidisciplinary approaches. *Ann Plast surgm*, 2011, 67: 551-564.
- Papagelopoulos P, Mavrogenis A, Mitsiokapa E, et al. Current trends in the management of extra-abdominal desmoid tumors. *World J Surg Oncol*, 2006, 4: 21-28.
- Nuytens J, Rust P, Thomas C, et al. Surgery versus radiation therapy for patients with aggressive fibromatosis or desmoid tumors. A comparative review of 22 articles. *Cancer*, 2000, 88: 1517-1523.
- Dempke W, Rie C, Grothey A, et al. Cyclooxygenase-2; a novel target for cancer chemotherapy. *J Cancer Res Clin Oncol*, 2001, 127: 411-417.
- 杨吉龙, 王坚, 朱雄增. 韧带样型纤维瘤病的病理学和遗传学研究进展. *中华病理学杂志*, 2005, 34: 537-539.
- Nieuwenhuis MH, Casparie M, Mathus-VLisbeth MH, et al. A nation-wide study comparing sporadic and familial adenomatous polyposis-related desmoid-type fibromatoses. *Int J Cancer*, 2011, 129: 256-261. DOI: 10. 1002/ijc. 25664.
- Rodriguez-Bigas MA, Mahoney MC, Karakousis CP, et al. Desmoid tumors in patients with familial adenomatous polyposis. *Cancer*, 1994, 74: 1270. DOI: 10. 1002/1097-0142(19940815)74:4<1270::AID-CNCR2820740415>3.0.CO;2-7.
- 杨吉龙, 王坚, 周晓燕, 等. 韧带样型纤维瘤病的临床病理学及遗传学研究. *中华病理学杂志*, 2006, 35: 145-150. DOI: 10. 3760/j. issn: 0529-5807. 2006. 03. 006.
- 王维, 杨学军, 王华民, 等. II 型神经纤维瘤病分子遗传分析指导临床个体化诊疗的研究. *中华神经医学杂志*, 2011, 10: 564-569. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1671-8925. 2011. 06. 007.
- Khorsand J, Karakousis CP. Desmoid tumor and their management. *Am J Surg*, 2005, 169: 215-218.
- Stoeckle E, Coindre JM, Longy AM, et al. Critical analysis of treatment strategies in desmoid tumors: a review of a series of 106 cases. *Eur J Surg Oncol*, 2009, 35: 129-134. DOI: 10. 1016/j. ejso. 2008. 06. 1495.
- Mike O, Seegenschmiedt MH. Radiation therapy for aggressive fibromatosis (Desmoid tumors): Results of a national patterns of care study. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*, 2005, 61: 882-891.
- 孙国志, 王猛, 朱卫红. 腹壁韧带样瘤 16 例临床分析. *中华疝和腹壁外科杂志: 电子版*, 2012, 6: 578-582. DOI: 10. 3877/cma. j. issn. 1674-392X. 2012. 01. 014.
- Mullen JT, Delaney TF, Kobayashi WK, et al. Desmoid tumor; analysis of prognostic factors and outcomes in a surgical series. *Ann Surg Oncol*, 2012, 19: 4028-4035. DOI: 10. 1245/s10434-012-2638-2.
- 杨维良, 张好刚, 张东伟. 86 例腹壁硬纤维瘤的临床分析. *中华普通外科杂志*, 2007, 22: 736-738. DOI: 10. 3760/j. issn: 1007-631X. 2007. 10. 006.
- La Greca G, Santangelo A, Primo S, et al. Clinical and diagnostic problems of desmoid-type fibromatosis of the mesentery: case report and review of the literature. *Ann Ital Chir*, 2014, 12: 85.

(收稿日期: 2016-03-04)